Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine
Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'enseignement intégré 2

Sémiologie cutanée

Pr Ouail

Objectifs pédagogiques

- Savoir reconnaitre et décrire les principales lésions élémentaires dermatologiques.
- Connaître la démarche diagnostic devant une atteinte cutanée ou muqueuse.

EXAMEN DE LA PEAU

Introduction

- L'examen facile : 2 minutes pour inspecter tout le corps
- Organe accessible à la vue et au toucher
- Devra intéresser systématiquement
  - La peau,
  - Les muqueuses
  - les phanères
- Comprend 3 temps :
  - L'interrogatoire
  - L'inspection
  - La palpation.

Interrogatoire

- L'interrogatoire va s'attacher à préciser les points suivants :
  - La date et le mode d'apparition des lésions.
  - Les circonstances écologiques :
    - Notion d'un contage septique,
    - D'application ou d'ingestion médicamenteuse,
    - D'exposition à certains agents physiques.
  - Les particularités évolutives :
    - évolution d'un seul tenant ou au contraire par poussées.

Interrogatoire

- Signes fonctionnels accompagnateurs: ·
  - Douleur localisée à type de cuisson ou de brûlure, douleur de type névralgique, telles qu'on peut les rencontrer au cours du zona (infection virale à tropisme neuroectodermique).
  - Prurit : la recherche de la notion de prurit est fondamentale. En effet ce signe est à la base de certaines classifications dermatologiques; c'est ainsi que l'on distingue :
    - Les dermatoses prurigineuses : exemple urticaire, eczéma;
    - Les dermatoses non prurigineuses : exemple psoriasis.

L'inspection

- Elle doit être :
  - Totale : le malade doit être entièrement dévêtu et l'examen doit concerner non seulement la peau en totalité, mais aussi les ongles, les poils et les cheveux.
  - Préparée : après nettoyage de la peau.
  - Bien éclairée : à la lumière du jour en s'aidant d'une loupe.
    - La lumière artificielle altère les couleurs

L'inspection

- Elle doit être :
  - Minutieuse : elle doit préciser
    - La topographie,
    - La dimension,
    - La teinte,
    - Les contours,
    - Le relief,
    - Le nombre
    - Le mode de groupement des lésions.
    - Elle va apprécier la couleur de la peau et rechercher une anomalie

La palpation

Sans lésion cutanée apparente

- La palpation doit systématiquement apprécier
  - La souplesse,
  - L'élasticité,
  - La température,
  - Le degré de sécheresse ou d'humidité : par exemple au cours du myxœdème (insuffisance thyroïdienne) les téguments sont épaissis et secs, au contraire en cas d'hyperthyroïdie les téguments sont chauds et humides.

La palpation

Sans lésion cutanée apparente

- La palpation se fait avec la pulpe et avec la face dorsale des doigts pour mieux percevoir les différences de température;
- Entre le pouce et l'index pour apprécier l'épaisseur et la souplesse de la peau.
  - la persistance du pli cutané signant un état de déshydratation.
  - La palpation permet également d'apprécier l'état du tissu sous-cutané : le degré d'adiposité; l'existence d'œdèmes sous-cutanés par la recherche du signe du godet.

La palpation

Avec lésions cutanées apparentes à l'inspection

- La palpation renseigne sur
  - La consistance : induration ou souplesse de la base d'implantation,
  - Recherche de l'adhérence aux plans profonds.
  - Par la vitro-pression, qui peut être remplacée par l'étirement de la peau entre le pouce et l'index, on peut faire la différence entre une lésion érythémateuse s'effaçant à la vitro pression et une lésion purpurique qui ne s'efface pas.
  - Le grattage des lésions peut mettre en évidence l'existence de squames.

LES ANOMALIES CUTANÉES

Introduction

- Modifications cutanées sans lésions
- Les lésions cutanées
- Anomalies des phanères
- Synthèse
- Analyse
- Diagnostic
- Examens complémentaires

MODIFICATIONS DE LA PEAU SANS LÉSIONS CUTANÉES

Coloration

- Changement remarquer par le patient ou son entourage:
  - Augmentation de la pigmentation brune
  - Un défaut de la pigmentation
  - Une rougeur
  - Une pâleur
  - Une cyanose
  - Une coloration anormale de la peau
  - Autres anomalies

Les hyperchromies

- Excès de mélanine; elles sont :
  - Soit diffuses : c'est la mélanodermie réalisant un brunissement diffus des téguments prédominant aux régions découvertes et aux régions normalement pigmentées et des taches ardoisées au niveau des muqueuses.

Les hyperchromies

– Soit localisées : ce sont les taches pigmentaires :
  - Le chloasma ou masque de grossesse.
  - Les éphélides ou taches de rousseur qui sont des macules brunâtres. — Les naevi : sont des taches pigmentaires le plus souvent congénitales s'accompagnant d'une modification de la texture des téguments : ce sont les naevi pigmentaires. Les naevi peuvent être également pileux ou vasculaires

Les hypochromies

- sont des défauts de mélanine ou leucodermies
- Elles réalisent une dépigmentation diffuse telle qu'elle est rencontrée dans l'albinisme par absence congénitale de pigment.

Les dyschromies mixtes

- Ce sont les leuco-mélanodermies où les taches hyperpigmentées voisinent avec des taches dépigmentées ; cette anomalie est réalisée au cours du vitiligo.

La rougeur

- L'érythème : est une coloration rouge, due à une vaso-dilatation des petits vaisseaux.
- L'érythrose : est une coloration rouge, due à une augmentation du nombre de globules rouges encore appelée polyglobulie. L'érythrose prédomine au niveau des parties découvertes et siège au niveau de la peau et des muqueuses.

La pâleur

- due :
  - Soit à une vasoconstriction des petits vaisseaux, exemple la pâleur au cours de la syncope.
  - Soit à une diminution du nombre de globules rouges, c'est la pâleur de l'anémie.

La cyanose

- Une coloration bleutée des téguments et des muqueuses due à une augmentation de l'hémoglobine réduite, supérieure à 5 g/100 ml dans le sang capillaire.

Colorations anormales

- Accumulation de bilirubine au niveau de la peau : coloration jaune au cours de l'ictère.
- Dépôt anormal de certains sels de métaux :
  - Coloration grisâtre après ingestion prolongée de médicaments à base d'argent, d'or ou de bismuth.

Autres anomalies

- Humidité : sècheresse, transpiration, aspect graisseux
- Température : élévation ou diminution localisée ou diffuse
- Texture : rugueuse ou lisse
- Mobilité : plissez la peau et noter la facilité avec laquelle le pli est constitué
- Turgor : la vitesse avec laquelle le pli s’efface

LES LÉSIONS CUTANÉES

Introduction

- Les lésions élémentaires primitives
- Les lésions élémentaires secondaires

LES LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES PRIMITIVES :

Les macules :

- c’est une simple modification tinctoriale de la peau, plane sans modification de l’épaisseur ni de la consistance, dont le diamètre est inférieur à cm.
- On distingue quatre types de macules :
  - Les macules Erythémateuses
  - Les macules Purpuriques
  - Les télangiectasies : c’est une ectasie des petits vaisseaux dermiques s’effaçant à la vitro-pression.
  - Les macules Dyschromiques : les dyschromies sont des modifications de la coloration normale des téguments.

Macule érythémateuse






(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131- 85 - 2727


(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131- 85 - 2727

Macule érythémateuse

Coup de soleil



Macule s'effaçant à la vitro pression



érythème

scarlatiniforme

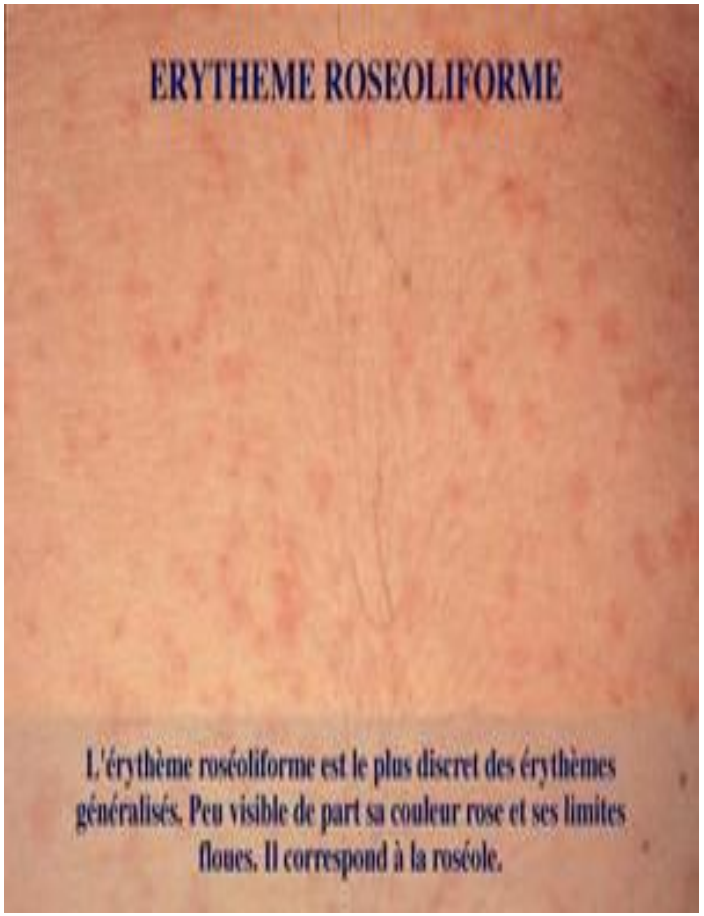


morbiliforme



Macule érythémateuse –roséoliforme-





Macules purpuriques





Macules dyschromique





Les lésions solides

- la papule est une élevure cutanée, circonscrite de moins de 01cm de diamètre, solide, due à un infiltrat superficiel, qui guérit sans séquelles.
- le nodule: une masse solide qui siège dans l'hypoderme, son diamètre est inferieur à 01cm.
- La nouure : elle a les mêmes caractéristiques que le nodule, mais son diamètre dépasse le 01 cm. La nouure est l'élément caractéristique de l'érythème noueux.

Les papules



Les nodules



Les végétations



Les lésions liquidiennes

- La vésicule : est une élevure circonscrite de la peau, de diamètre inférieur à 01 cm, contenant une sérosité. La vésicule est une lésion fragile et transitoire qui évolue en quelques heures à quelques jours vers
  - ***La rupture :*** laissant s'écouler une sérosité claire et laissant place à une érosion suintante, puis à une croûte.
  - ***La coalescence :*** réalisant des bulles.
  - ***La pustulisation :*** le contenu liquidien se trouble (pus).

Les vésicules



Les lésions liquidiennes

- **La bulle ou phlyctène :** possède les même caractères que la vésicule, elle en est différente par la taille qui est supérieure à 01 cm. Comme la vésicule, la bulle est une lésion fragile qui évolue vers la rupture ou la pustulisation.
- **La pustule :** est semblable à la vésicule, son contenu est purulant. Les pustules peuvent être : **folliculaires. Non folliculaires.**
- **Le kyste :** est une cavité remplie de liquide et situé dans le derme ou l'hypoderme.

Les bulles


(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131- 85 - 2727

Pustules





LES LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES SECONDAIRES :

Définitions:

- Les squames : sont des lamelles épidermiques détachées de la couche cornée.
- **Les croutes :** représentent un exsudat desséché sur la peau, se voit au cours de l'impétigo.
- Les fissures : sont des déchirures ou fentes de l'épiderme.
- Les érosions : sont des pertes partielles intéressant la couche superficielle de la peau ou d'une muqueuse. Elles guérissent sans séquelles.
- Les ulcérations : sont des zones où la perte de l'épithélium de la peau ou de la muqueuse et totale. Elles guérissent en laissant des cicatrices indélébiles

Les squames


CLINIQUE DERMATOLOGIQUE
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE NANTES
© Clinique Dermatologique - CHU NANTES

Les croutes:



Les érosions



Les ulcérations



LES LÉSIONS MUQUEUSES :

La muqueuse buccale

- **La leucokératose : la leucoplasie :** épaississement de l'épithélium muqueux (exemple : leucokératose tabagique). C'est une lésion précancéreuse, l'étude anapath de la biopsie est obligatoire.
- **Erosions buccales :** aphtes, herpès.

Aphtose buccale



Leucoplasie buccale



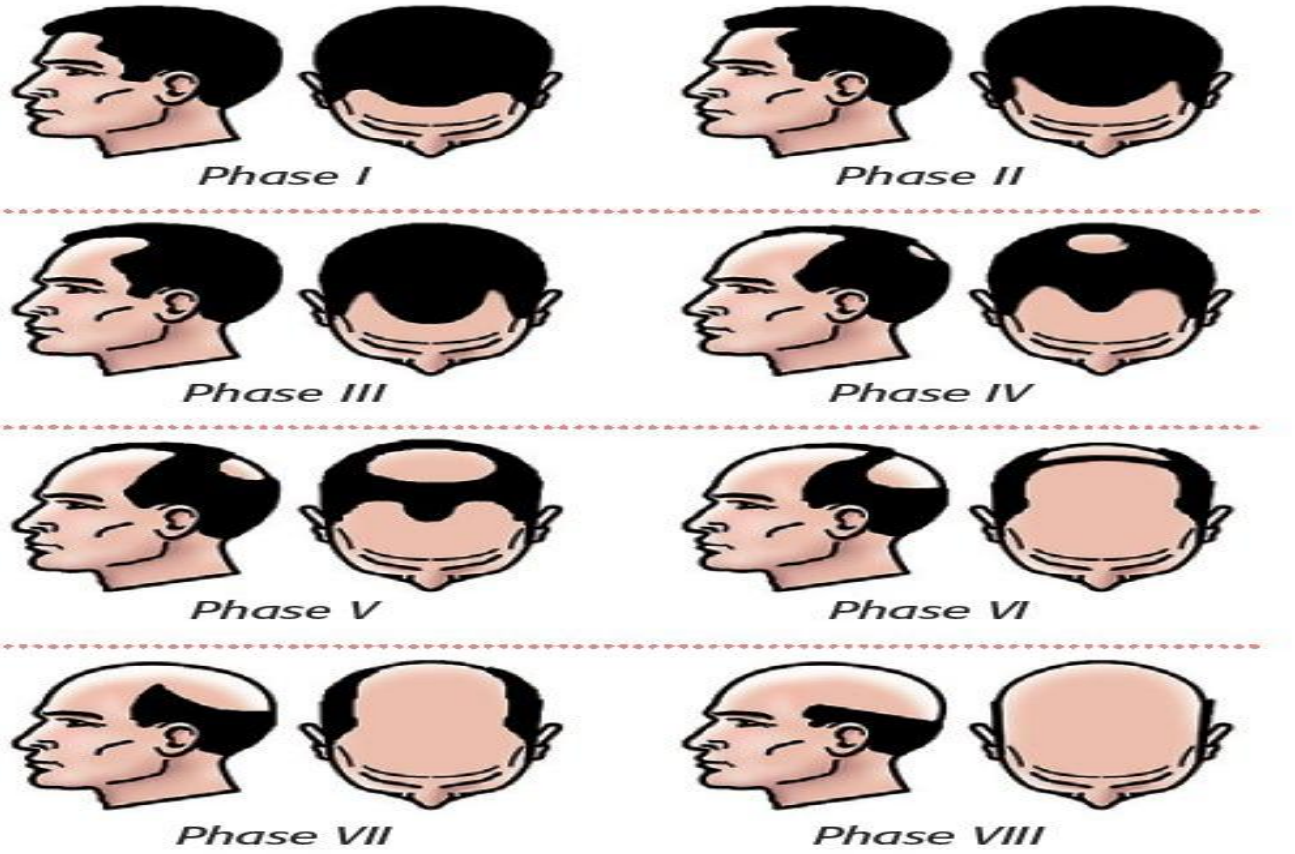
La muqueuse génitale

- **Chez l'homme :**
  - ***Balanite érythémateuse :*** candidosique, maladie de Bowen.
  - ***Ulcération :*** herpes, aphte, chancre.
- **Chez la femme :** vulvovaginite infectieuse.

L’ATTEINTE DES CHEVEUX :

- **L’alopécie :** l’alopécie est une raréfaction ou une disparition transitoire ou définitive, localisée ou diffuse de la pilosité.
- **La canitie :** c’est la décoloration acquise des cheveux.
- **Les trichoclasies :** sont des fractures du poils dans le sens transversal ou langitudinal.

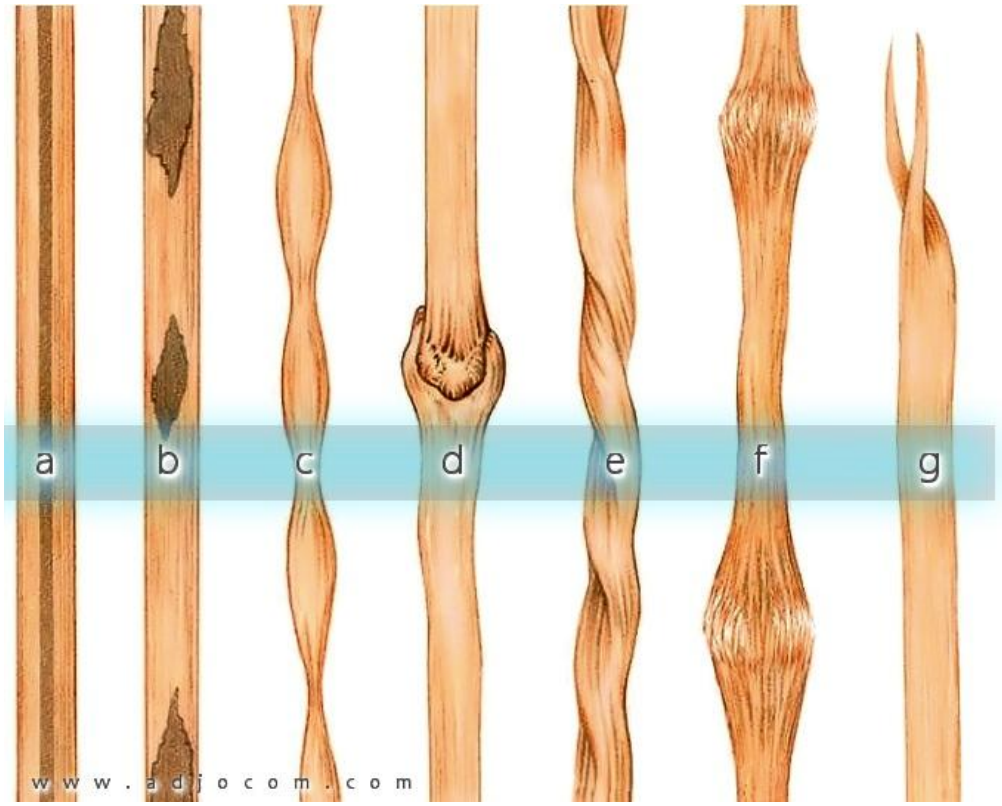
Alopécie masculine



La canitie



trichoclasies



Anomalies du cheveu

Pathologies, maladies du cheveu

a : cheveu normal

b : pili annulati

c : monilethrix

d : trichorrhexis invaginata

e : pili torti

f : trichorrhexis nodosa

g : trichoptilosis

L’ATTEINTE DES ONGLES :

Définitions:

- **L'Onycholyse :** c'est la destruction de l'ongle.
- **Le Périonyxis :** est l'inflammation des replis péri-unguéaux.
- **La Mélanonychie :** coloration brune, bleu foncé ou noir, intéressant un ou plusieurs ongle.
- **La Pachyonychie :** épaississement de l'ongle, elle est due à une hyperkératose du lit unguéal.
- **La koïlonychie :** ongle en cuvette, héréditaire ou acquise (anémie hypochrome, carence en vitamine C).
- **Hippocratisme unguéal :** ongle en verre de montre.

onycholyse



Périonyxis



Mélanonychie



Pachyonychie



Hippocratisme digital



Koilonychie



LES SIGNES FONCTIONNELS :

Le prurit :

la recherche de la notion de prurit est fondamentale. En effet ce signe est à la base de certaines classifications dermatologique :

- Les dermatoses prurigineuses : urticaire, eczéma…
- Les dermatoses non prurigineuses : psoriasis...

Autres signes :

- brûlure,
- cuissons,
- douleurs

LA DÉMARCHE DIAGNOSTIC :

L’interrogatoire :

Doit préciser :

- Le mode de début : brutal ou progressif.
- La localisation initiale : localisée ou étendue.
- Le mode d’extension : centrifuge, en plaques.
- Le mode évolutif : Aigu, chronique ou par poussées.
- Les signes associés : prurit, douleur….
- Les traitements utilisés : par voie locale ou générale.

L’examen physique :

- Les anomalies cutanées doivent être analyser selon la séquence suivante :
- Inspection.
- Palpation
- Vitropression.
- Friction.
- Curetage.

L’examen physique

identifier le groupement des éléments :

- Isolé.
- Groupés :
  - En plaque < 10 cm.
  - En nappe (en placard) > 10 cm.
  - Universalis : l’ensemble des téguments avec 10 à 20% de peau saine.
  - Punctiforme.
  - Lenticulaire : 3 à 5 mm.
- Nummulaire : en pièce de monnaie.

L’examen physique

Identifier la topographie

- Non élective ou ubiquitaire.
- Elective : uni ou bilatérale, symétrique ou asymétrique.

identifier les signes fonctionnels associés :

- Prurit : dermatose prurigineuse.
- Pas de prurit : dermatose non prurigineuse.*

identifier les signes généraux :

- Fièvre.
- Asthénie.

Synthèse :

Au terme de l'examen clinique, le médecin doit être capable de mettre une étiquette sur la maladie dermatologique, permettra ensuite de porter un diagnostic étiologique.

Dans les cas difficile des examens complémentaires peuvent être envisagés :

- La biopsie cutanée avec étude histopathologique.
- Les réactions d'immuno-fluorescence.
- Les explorations allergologiques.
- Les examens mycologiques.
- Des examens microbiologiques.

La photographie



Dermatoscope

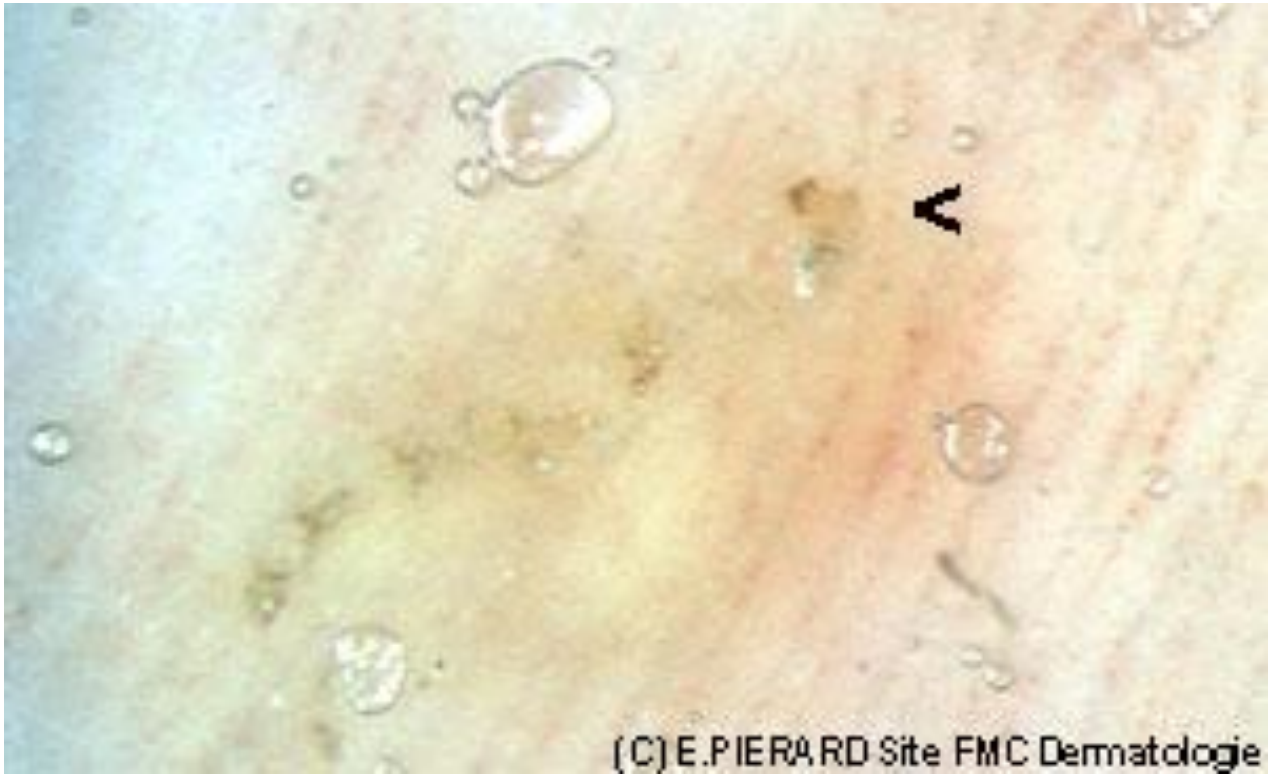




Handyscope



Photo de dermatoscopie de sarcopte



Prélèvements microbiologiques

- Mycologiques: peau, muqueuse, ongle
  - Racler, gratter
  - Lésion non traitée
  - Couton, bistouri, écouvillon
  - Prélèvement des poils, cheveux, fragment d'ongles



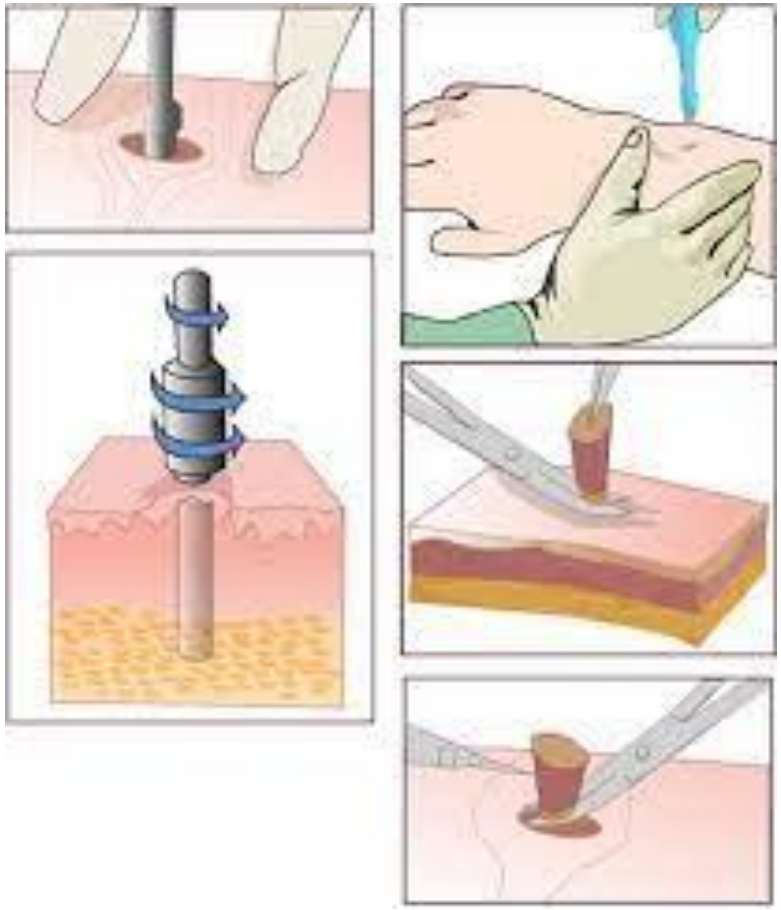
Prélèvements microbiologiques

- Bactériologiques:
  - Lésion ouverte: écouvillonnage
  - Lésion fermée:
    - Piquer avec une aiguille et aspirer à la seringue
  - Examen direct et culture

Tests allergologiques

- Allergie de contact: patch-tests
  - Lecture en 48 H - 72H
- Allergies alimentaires ou respiratoires: pricks --tests
  - Face antérieure de l'Avant Bras
  - Micropiqures
  - Lecture immédiate 15 minutes

La biopsie cutanée



LES ÉRUPTIONS CUTANÉES ACCOMPAGNANT LES MALADIES INFECTIEUSES APPELÉES FIÈVRES ÉRUPTIVES

Introduction

- L' exanthème : éruption cutanée
- L’énanthème : éruption au niveau des muqueuses.
- Les principales fièvres éruptives sont :
  - La scarlatine.
  - La rougeole
  - La rubéole :
  - La varicelle :
  - Le zona :
  - La variole

La scarlatine

- qui réalise une éruption
  - Érythémateuse
  - Diffuse
  - Faite de nappes rouges
    - Confluentes
    - Sans intervalle de peau saine
  - s'accompagnant d'une sensation de cuisson.



La rougeole

- Caractérisée par un exanthème dite morbiliforme fait de macules :
  - Rouges,
  - Irrégulières,
  - Inégales,
  - Non confluentes.
- Un énanthème caractéristique, le signe de Koplick, fait d'un
  - Semis de petits points blanchâtres saupoudrant une muqueuse jugale érythémateuse, précède l'exanthème.

La rougeole



La rubéole

une éruption érythémato-maculeuse.



La varicelle

Réalise une éruption vésiculeuse diffuse.



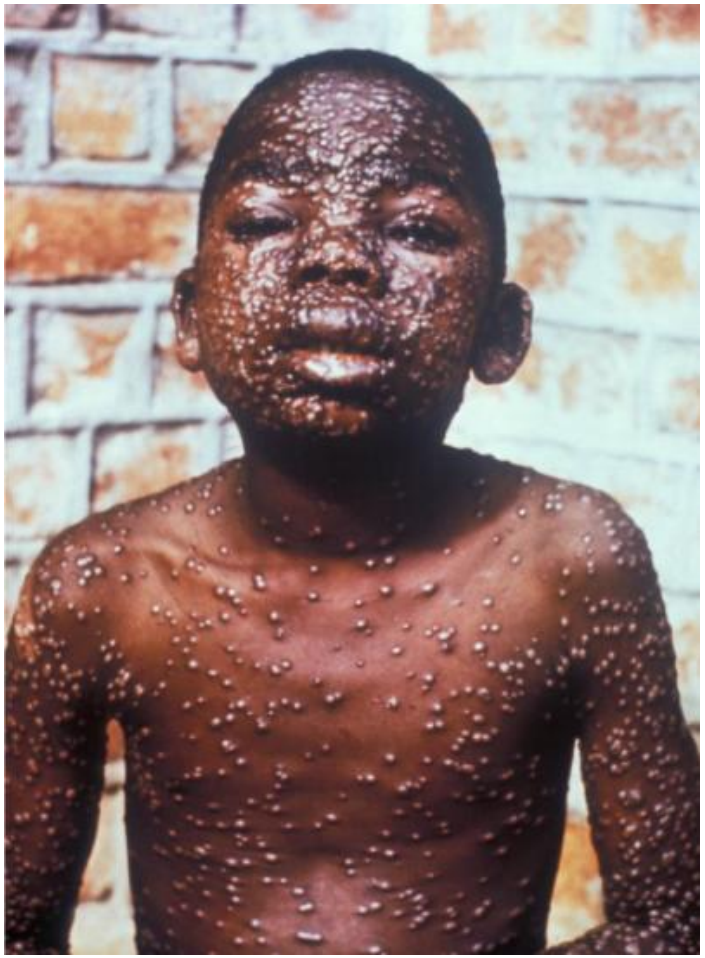
Le zona

- Réalise une éruption vésiculeuse localisée
- De topographie radiculaire ou métamérique
- Accompagnée de douleurs de même topographie.



La variole

- À la phase d'état est caractérisée par une éruption pustuleuse



DÉPISTAGE DE MÉLANOME

Examen des grains de beauté

« Rechercher le vilain petit canard » ABCDE

- A : asymétrie des bords
- B: bords irréguliers, déchiqueté
- C : changement de couleur
- D : diamètre > ou égal 6 mm
- E : évolution, changement de taille, symptomatologie ou morphologie

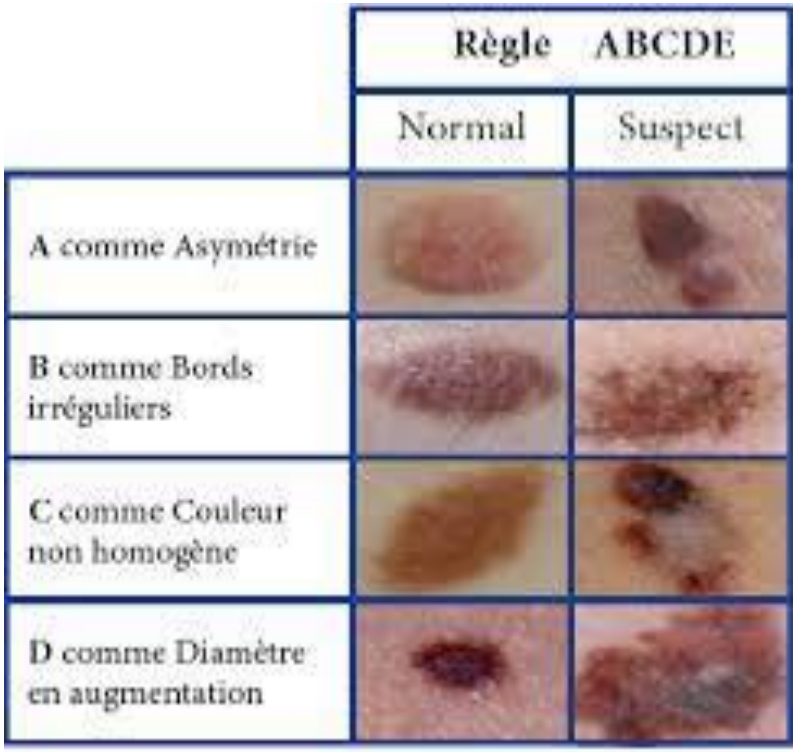


Tableau réalisé selon le site de l'Institut National du Cancer

Conclusion :

- Le diagnostic en dermatologie repose sur un interrogatoire bien conduit, un examen clinique méthodique permettant d'identifier la lésion élémentaire.
- Dans certains cas difficile le recours à des examens complémentaires orientés par les données de la clinique s'impose. La confrontation des données cliniques aux données paracliniques permet d'établir un diagnostic précis et d'instituer un traitement adéquat